

22 - 01- Présentation du sommet (Audio) - Pr. HAROU

importante, parce que c'est la présentation qui est la plus fréquente au cours de l'accouchement, la présentation de sommet. Le cours de la présentation de sommet, il ressemble au cours de l'accouchement normal, parce que quand on parle d'accouchement normal, on est censé avoir une condition concernant la position du bébé, et qui est la présentation de sommet. On vous l'a dit.

On vous a dit que 95% des accouchements, c'est en présentation de sommet. Alors il faut faire la différence entre une présentation de sommet et une présentation céphalique, parce que ce n'est pas la même chose. Qui peut nous dire la différence ? Oui ? Très bien.

Quelles sont les autres présentations céphaliques ? Les trois. Donc, il y a la présentation céphalique, il y a deux types. Il y a la présentation fléchie, et la présentation défléchie.

La présentation fléchie, vous avez une seule, c'est la présentation de sommet. Et les autres sont des présentations défléchies, comme la définition le marque, c'est une déflexion de la tête. Elle est soit totale, et on parle de présentation de face, intermédiaire, présentation de front, ou là, avec un angle moindre, donc on a dit totale, deux tiers, et le tiers, c'est la présentation de bergman.

C'est le degré de déflexion qui diffère entre les trois. Je crois que vous n'avez pas eu le cours sur les présentations défléchies, parce que les présentations défléchies, on les regroupe sur un seul groupe, puisqu'ils représentent une seule entité, c'est la déflexion. La présentation de sommet, elle est dans l'autre groupe, qui est la présentation fléchie, et on va distinguer deux présentations fléchies, la présentation de sommet, en fonction de la variété.

Vous avez les présentations de sommet fléchies en variété antérieure, et les présentations fléchies en variété postérieure. Quelle est la différence entre une variété antérieure et une variété postérieure ? Comment peut-on faire la différence ? Parce que cette notion est très importante, la flexion. Imaginons qu'on va schématiser le bassin sous forme d'un cercle.

On va dessiner un cercle, on va imaginer que cette partie-là constitue le pubis, et cette partie-là le sacrum, et ça c'est les ailes iliaques, donc le pourtour du bassin. Et ça c'est une vue périnéale, c'est-à-dire imaginez qu'on regarde le bassin par la vue périnéale, c'est-à-dire la patiente en position gynécologique. Vue du périnée.

Vous savez que le bassin ça dépendra, on peut le schématiser en fonction de la position avec laquelle on le visualise, soit de façon latérale, ou en supérieure, ou en vue périnéale inférieure, et donc nos repères essentiellement c'est le pubis et le sacrum. Alors ça c'est le repère du bassin, c'est-à-dire la mer. Concernant le fœtus, quels sont les repères ? La tête, l'occipite, oui.

Alors si on veut schématiser un crâne fœtal en vue supérieure, on va imaginer que ça c'est la

racine du nez, ça c'est les joues, ça c'est les yeux, les joues. Donc c'est une vue supérieure, vous avez l'occipite à ce niveau et le front à ce niveau. C'est comme si on regardait la tête comme ça.

Vous allez visualiser deux éléments importants. D'abord une fontanelle triangulaire qui est postérieure, qui est occipitale, et vous avez les sutures sagittales, on va schématiser, et vous aurez une fontanelle antérieure qui est losangique. Cette fontanelle on appelle le prégnat et cette fontanelle c'est la lambda.

Fontanelle antérieure, fontanelle postérieure. En fonction de ces fontanelles, la position de ces fontanelles, on va décider de la variété. Vous voyez ça c'est quoi ? C'est une sorte de boîte, le contenant.

Et ça c'est le contenu, c'est-à-dire on va mettre cette tête à l'intérieur. Et de là, vous avez toutes les notions de mécanique obstétricale, c'est-à-dire, ces diamètres-là normalement devraient être inférieurs au diamètre du bassin. Parce que cette tête, si on la schématise comme ça, on va la mettre par exemple comme ça.

De vue supérieure, c'est comme si vous regardez le bébé en accouchement. C'est comme ça que ça va se présenter. Il va se présenter avec la tête et tous les éléments.

Et vous avez la position de cette fontanelle par rapport à l'ociliaque, au pubis, va déterminer la variété. Lorsqu'elle se trouve sur la moitié antérieure, on parle de variété antérieure. Lorsqu'elle se retrouve en moitié postérieure, on parle de variété postérieure.

C'est clair ? Là, c'est un peu flou. J'essaie de schématiser au maximum. Et on va parler de variété antérieure et variété postérieure.

Alors, est-ce qu'on peut affiner le cheveu pour le rendre plus fin ? Comme ça. Donc, les variétés antérieures, on a occipito-iliaque-gauche-antérieure, occipito-iliaque-gauche-postérieure. Ça, c'est les présentations les plus fréquentes.

Mais vous avez aussi les occipito-iliaques-droite-antérieure et les occipito-iliaques-droite-postérieure. Vous voyez le P avec le P et le A avec le A. Je m'explique. On commence toujours par l'occipite, occipito.

Il se trouve occipito-iliaque. Gauche ou la droite ? On a affiné la gauche ou la droite ? Si je vous dis que c'est une vue pérenniale, vue d'accouchement. Comme ça ou là comme ça ? Comme ça ? Là, ça, c'est quoi ? La gauche.

Ça, c'est la droite. Donc, occipito-iliaque-gauche-antérieure. D'accord ? Occipito-iliaque-gauche-antérieure.

Si je vous fais ça, on va à l'oxygène. On va le deviner comme ça. C'est quoi comme variété ? Occipito-iliaque-droite-postérieure.

Ça fait le même truc. Donc, comment on fait le diagnostic à l'examen clinique ? Parce que la présentation de sommet, quel est le repère de la présentation de sommet ? La fontanelle postérieure, effectivement. Qui est ? De quelle forme ? Triangulaire.

Donc, le toucher vaginal, on va venir rechercher cette fontanelle postérieure. Les fonctions orales se trouveront. On va déterminer la variété.

Bien sûr, peut-être que vous l'avez bien compris, lorsque la présentation est vraiment fléchie, la fontanelle antérieure, qui est le brégma, ne serait pas palpable dans une présentation de sommet. Parce que si vous la palpez, c'est un brégma. Il ne faut pas que vous palperez les autres repères.

Les autres présentations de fléchies, lesquelles ? Pour la variété de brégma, c'est le brégma. Pour le front, c'est la racine du nez. Et pour la face, c'est le menton.

Pas de menton palpable, pas de racine du nez palpable, pas de brégma palpable. Uniquement fontanelle postérieure. Fontanelle postérieure détermine la variété.

En fonction de sa position dans le bassin. Et en fonction de ça, on peut plus ou moins deviner l'issue de l'accouchement. D'accord ? Comment devrait se faire l'accouchement ici ? Vous avez eu les étapes de l'accouchement ? Non ? Le travail normal.

Qu'est-ce qu'on vous a parlé dans le travail ? Les contractions ? Après les contractions, la dilatation cervicale, après on vous a pas parlé de différentes phases du travail ? Quel est l'élément clé dans l'accouchement ? A votre avis, quelle est la variété la plus fréquente ? Déjà. Les antérieures ou les postérieures ? Non, les antérieures. Les antérieures, quelle est la variété la plus fréquente ? La gauche ou l'antérieure ? Oui.

Ça représente presque 60% des cas. Les autres partagent les 40%. Vous avez 60% pour le IGA, à peu près... Alors la droite antérieure est très rare, et la droite postérieure présente à peu près 38%, et la gauche postérieure à peu près 6%.

Et ça, vous l'aurez dans le cours. Et donc, l'élément clé, parce que quand je vous fais ce schéma-là, ça veut dire que la tête est engagée et qu'elle concorde avec le diamètre du D3 supérieur. Vous avez eu le cours, peut-être, que le D3 supérieur, il y a deux diamètres importants, il y a le diamètre promonto-rétropubien, donc la région rétropubienne, mais là, un peu plus oblique comme ça, ça veut dire que c'est le promontoire qui est au-dessus du sacrum, promonto-rétropubien, et vous avez le diamètre transverse, soit médian, soit maximum.

Et puis vous avez le diamètre oblique, soit oblique gauche, ou oblique droit, et en fonction. Là, c'est l'oblique droit, par exemple. Donc, en général, l'engagement se fait dans un diamètre oblique.

Vous aurez toujours la tête comme ça, qui prend un diamètre oblique. En général, le gauche. Par la suite, le bébé, par le biais des contractions utérines, va essayer de ramener sa fontanelle postérieure dans un plan axial.

Et en général, la meilleure façon, le meilleur diamètre pour que le bébé sorte, c'est qu'il fasse un détour, qu'il ramène sa fontanelle postérieure au-dessous du pubis. C'est pour ça que la gauche, comme on a parlé de la gauche, c'est plus facile, c'est un angle de 45 degrés. Alors qu'ici, c'est un angle de 135 degrés.

45 degrés. Parfois, cela nécessite, bien sûr, la rotation. C'est la deuxième phase.

La rotation et la descente, il doit tourner. Parfois, la musculature n'est pas très importante et la rotation va se faire plutôt vers le sacrum. Et donc l'accouchement va se faire soit en occipito pubien, soit en occipito sacré, selon la position adoptée par le bébé et la position de la fontanelle postérieure par rapport au pubis.

C'est clair ? Il y a un moyen de faire disparaître tout ça. Le deuxième page. Voilà, deuxième page.

C'est pour cela que l'étude de la présentation de sommet implique l'étude du contenant et du contenu. Le contenant, c'est quoi ? Le bassin. Quel type de bassin ? Le bassin est large.

C'est quoi le bassin obstétrique ? Il y a un bassin non obstétrique. Hein ? Le bassin obstétrique. Le bassin non obstétrique.

Je ne vois le bassin obstétrique, le bassin non obstétrique. On va schématiser ça. On va dire que ça c'est le sacrum.

On va supposer que ça c'est les iliaques. Ça va se faire comme ça avec l'épine ici. Voilà.

Donc les épines. Vous voyez que le bassin n'est pas... Il y a une autre pièce qui manque ici, c'est la partie inférieure du bassin, qui est l'esquillon. On va faire en sorte de schématiser.

On va dire que ça c'est le pubis iliaque. C'est schématique parce qu'il y a plusieurs pièces. Ça c'est l'esquillon.

Ça c'est les iliaques. Ça c'est l'articulation sacroilière. Donc ça c'est le promontoire.

Ça c'est la région pubienne. La région pubienne, le promontoire. Ça c'est les iliaques.

L'esquillon. L'ilion. Et donc, vous voyez, c'est cette partie-là.

Alors il y a deux parties du bassin. On va dire le bassin obstétrical, d'ici. C'est le bassin béot, le bassin obstétrical.

C'est cette partie qui va du promontoire au-dessous, d'accord, jusqu'au coccyx et même le pubis vers le bas, jusqu'aux épines ischiatiques. Et la partie haute du bassin, le bassin haut, le bassin obstétrical, c'est la partie haute du bassin. La différence entre les deux, c'est que ce bassin est très large, on va dire, ouverture cubière.

Et au fur et à mesure qu'on va descendre, vous voyez, c'est une sorte d'entonnoir. Et donc, le premier cylindre est très vaste. C'est là où loge le bébé pendant les neuf mois de grossesse, donc il est très haut, dans le bassin maternel, mais pas dans le bassin obstétrical.

Et le bassin obstétrical, c'est la partie où va se faire l'accouchement. C'est-à-dire que le bébé n'est pas serré dans le petit bassin. Alors, on parle de grand bassin, grand bassin et petit bassin.

Le petit bassin, c'est le bassin obstétrical, le grand bassin, c'est le bassin au-dessus du petit bassin, qui en général n'intervient pas dans l'accouchement. D'accord ? Le problème du petit bassin, c'est ses contraintes mécaniques. Ses contraintes mécaniques parce que les ouvertures ne sont pas très généreuses.

D'accord ? Toujours dans le contenant, on va schématiser ce petit bassin, comme ça, l'entonnoir, et trois parties. Vous les connaissez. Qui sont ces trois parties ? Le D3 supérieur, le D3 moyen, le D3 inférieur.

Vous connaissez les repères de chaque D3 ? Vous avez étudié ça, mais pas avec ces détails. Donc, on schématise. Le D3 supérieur, c'est une ouverture supérieure.

Le D3 inférieur, c'est l'ouverture inférieure. Et entre les deux, l'entonnoir, c'est le D3 moyen. D'accord ? Le D3 correspond à trois mouvements, trois actions.

Première action, l'engagement. Le D3 supérieur. Deuxième action, descente, rotation.

Le D3 moyen. Troisième action, dégagement. Le D3 inférieur.

Donc, pour chaque D3 correspond un mouvement obstétrical, un mouvement de mécanique obstétrique. Vous voyez qu'à votre avis, quelle est la phase la plus difficile ? Dégagement, la rotation, descente, ou bien l'engagement. Pourquoi ? Vous avez dit juste que c'est difficile.

Regardez le D3 inférieur. C'est la zone de transition. À votre avis, pourquoi serait-ce difficile ? Tout simplement parce qu'une fois qu'il a franchi le D3 supérieur, il est déjà accommodé au bassin.

Mais le D3 supérieur, il devrait y avoir des accommodations avant le franchissement du D3 supérieur. Et toute erreur de ces accommodations peut se solder d'un défaut d'engagement, qui est une cause fréquente de césariennes. Il y a beaucoup de patientes, on les césarise parce qu'il y a un défaut d'engagement, parce que le bébé n'arrive pas à trouver la position et le diamètre idéal pour pénétrer le D3 supérieur.

Ce n'est pas toujours la faute du bébé. Parfois c'est la faute du bébé ou la faute de la maman, à cause du bassin rétréci ou d'un macrosome avec une grosse tête, mais parfois c'est l'erreur des médecins qui font qu'ils mettent les patients dans des positions où les diamètres ne sont pas favorables. Les positions maternelles sont très importantes parce qu'elles vont favoriser une action ou l'autre.

Il y a des positions qui favorisent l'engagement, il y a des positions qui favorisent le dégagement. Cette science de la mécanique obstétrique en général est maîtrisée par les sages-femmes. En général ce n'est pas les obstétriciens, ce n'est pas le médecin généraliste, mais l'obstétricien et surtout les sages-femmes.

Parce que c'est les sages-femmes qui sont tout le temps avec les patients, les accompagnent, etc. Donc on va voir chaque partie du contenant avec ses diamètres. Est-ce qu'il y a d'autres contenants ? Hum ? Ça fait rire le bassin.

Eh bien vous avez tout le reste. Là, les ligaments, les muscles. Est-ce que là vous avez des muscles ? Les ligaments.

C'est couvert de parties molles. En général on parle de parties molles. Les parties molles sont tous les autres tissus qui matlassent le bassin.

Et l'un des muscles les plus importants, c'est les muscles élévateurs de l'anus. Parce qu'ils vont être des muscles très importants dans la mécanique obstétrique. Au moment où ils vont aider le bébé à faire la rotation, la descente et le dégagement.

Et c'est ce qu'on coupe au cours d'une épisiotomie. Parfois lorsqu'ils sont rigides, ils ne laissent pas franchir les trous inférieurs, on va les couper pour favoriser le diamètre du détroit inférieur, pour favoriser le dégagement. C'est ce qu'on coupe d'ailleurs au cours d'une épisiotomie.

Donc il n'y a pas que l'os qui peut entraver l'accouchement, il y a aussi les muscles. Donc ça c'est le contenant. Revenons maintenant au détroit supérieur.

Puisque vous avez dit que le détroit supérieur est la chose la plus importante, la plus difficile d'ailleurs, est-ce qu'il y a des moyens diagnostiques pour un petit peu apprécier le diamètre ou l'ouverture du détroit supérieur ? La palpation abdominale, oui, elle cherche quoi ? Est-ce qu'on peut à la palpation abdominale apprécier ? Oui, le bébé oui, mais comment peut-on apprécier le détroit supérieur ? Les épines, on ne peut pas les palper par la palpation abdominale. Oui, élevée maîtrise, c'est-à-dire ? Par quoi, comment ? L'échographie ? L'échographie en fait ? Je regarde, c'est juste une réflexion personnelle ? C'est juste une réflexion personnelle ? Peut-être que ça va venir dans l'avenir, qui sait ? Dans tous les cas actuellement, ce n'est pas le bon moyen de faire les mesures. Avant il y avait les scanners.

La scannopelvimétrie. Parce que les scanners on voit très bien l'os, on peut voir le diamètre. Le

problème du scanner c'est l'irradiation.

Donc on a abandonné, à un certain moment on le faisait pour toute première part, après on l'a abandonné. Il y a eu des petits soucis, surtout plus psychologiques que réels, parce qu'on a accusé ces médecins d'irradier les bébés, alors que ces bébés-là peuvent être irradiés autrement en dehors du scanner, parce que la dose d'irradiation du scanner n'est pas très importante. En plus en 1,5 mois ça ne pose pas de problème.

Mais scannopelvimétrie, actuellement c'est en fait de la pelvimétrie clinique. Pelvimétrie c'est les mesures du bassin clinique, en utilisant nos mains. Et nos mains c'est le toucher vaginal.

Parce que le toucher vaginal, on va schématiser ça pour vous expliquer comment on fait une pelvimétrie. Donc en même temps ce cours va vous permettre d'acquérir les bases de la mécanique obstétrique, parce que normalement c'est l'accouchement normal. Ma question c'est l'accouchement normal.

L'accouchement. Quand on met les bases de l'accouchement en général, on va schématiser le promontoire. On va dire celle-là c'est l'articulation, ça c'est l5, ça c'est les 6, c'est le pubis.

Vous voyez que là c'est cette ouverture. On va schématiser l'entonnoir comme ça. Et donc l'un des diamètres les plus importants, c'est le promontoire qui est là.

PRP. Comment on peut le mesurer ? Vous faites le toucher vaginal, et vous allez vous diriger vers le promontoire. Normalement, tu es en train de faire un toucher là.

Tu imagines, vas-y, une manœuvre. Tu as oublié quoi ? Tu l'as étudié où ? Le cours ? Oui, il y a une manœuvre. D'accord.

Pour les manœuvres, il faut juste retenir que la règle la plus simple, il faut simplifier les choses, pas compliquer les choses. Le promontoire, je précise, pour des doigts normaux, parce que bien sûr il y a des gens qui ont des doigts moyens. Montrez-moi vos mains.

Ah, c'est ce que j'avais. Regarde, tu n'as pas compris. C'est le moyen.

Donc pour des doigts moyens, en général, vous ne devez pas toucher le promontoire. Si vous le touchez, ça veut dire qu'il est proche. D'accord ? Vous devez aller au-delà de 11 centimètres.

Comment font vos doigts ? Plus de 11 ? Donc ce qu'il fait, vous ne devez pas toucher le promontoire. Si vous le touchez, attention, ce diamètre, probablement il est rétréci. Si vous ne le touchez pas, c'est une bonne chose.

D'accord ? C'est le plan antéropostérieur. Mais il y a un autre plan. Il y a le plan transversal.

D'accord ? Et on devrait faire un autre schéma. Sur le... C'est celui-là. Alors, le deuxième diamètre, on va imaginer toujours le pubis.

On va juste imaginer que ça, c'est les épines. Les épines sont dans un plan un peu plus inférieur. Et donc, le pubis, il est là.

On va dire le promontoire est là. Vous avez déjà le promontoire rétropubien. Mais vous avez aussi les ailes.

C'est simple. Il ne faut pas les suivre au-delà des deux tiers. Si vous arrivez à les suivre par le doigt, vous arrivez jusque-là, ça veut dire que probablement le bassin est rétréci transversalement.

Alors, le premier examen, c'est le rétrécissement antéropostérieur. Et ça, c'est le rétrécissement transversal. Deux choses très importantes.

On ne peut pas cliniquement apprécier le diamètre. On ne peut pas ouvrir les mains pour apprécier le diamètre transversal. Est-ce que c'est à peu près 12 cm ? C'est là.

On ne peut pas apprécier. Donc, on essaie de voir la courbure pour voir si ce diamètre-là est rétréci transversalement. Deux choses importantes.

Promontoire rétropubien et diamètre inominé. Par contre, le détroit moyen, il est par nature, comme je vous ai dit, une fois franchi le détroit supérieur, il est large. Mais par contre, c'est un cylindre.

Ce cylindre, il est rétréci sur une seule portion. Sur la portion où il y a les épines sciatiques. Et donc, on va chercher à voir la distance entre les deux épines sciatiques.

Le diamètre semi-tour, le diamètre bi-sciatique ou la-bi-épineux, puisqu'il est entre les deux épines. C'est un peu plus aléatoire parce qu'on doit chercher une épine. Et on doit imaginer la distance entre les deux.

Vous voyez que ça nécessite de l'expérience. Il faut déjà palper les bassins normaux pour que vous puissiez dire ça c'est un bassin anormal. D'accord ? Et puis vous avez le même schéma.

Ça c'est vue pérennielle, mais on regarde un petit peu la partie supérieure. On peut regarder la partie inférieure. Qui est la partie qui correspond au détroit inférieur.

La partie qui se présente à nous directement après l'accouchement. C'est-à-dire au moment de l'accouchement. Et c'est une partie où vous aurez le sacrum ou le lachorum.

Et on va faire comme ça. Vous aurez les épines ischiatiques. Les ischiants.

Vous pouvez palper sous les fesses. Les ischiants. Et ça, vous n'aurez pas besoin de toucher vaginal parce que vous pouvez palper les ischiants.

On demande à la patiente de fléchir les jambes. Position gynécologique. Et palper sous les fesses deux épines osseuses.

Et vous calculez le diamètre par un mètre. C'est le diamètre bihischiatique. D'accord ? C'est donc le diamètre bihischiatique.

Vous voyez qu'on... Ça, c'est le diamètre le plus important. Maintenant, il y a d'autres diamètres. Quels sont les diamètres les plus importants ? Imaginez un crâne foetal.

Voilà. Comme ça. Là, c'est... Et là, c'est notre fameuse fontanelle antérieure.

Le diamètre à votre avis, quel est le diamètre qui va s'exposer ? On va dire que ça, c'est le menton. Le menton. La racine du nez.

Et le diamètre le plus petit ? Ça, c'est l'occipite. Vous allez voir que dans la présentation du sommet, le bébé va tellement fléchir la tête que la partie qui va être confrontée au bassin, c'est cette partie-là. C'est ce diamètre-là.

Ça veut dire que c'est cette boule-là. D'accord ? Alors que... On va dire... Alors que dans la face, vous avez ce diamètre-là. Vous voyez la différence ? Dans le sommet, ça s'appelle le sous-occipito pragmatique qui est 9,5 cm.

Là, c'est le sous-mentopragmatique. Le sous-mentopragmatique. Excusez-moi.

La face, c'est ça. Sous-mentopragmatique, je veux dire. Mais le menton, le pragmatique.

Par contre, dans la face, c'est ce diamètre-là qui est un peu plus décalé ici. Ça s'appelle le syncipitomentonique. Syncipitomentonique.

C'est 13 cm qui est incompatible avec l'accouchement normal. Et vous voyez que la présentation de face, elle est en partie compatible avec l'accouchement normal dans une sorte, une partie. Mais le front, il n'est jamais compatible.

Parce que c'est le diamètre le plus grand. Mais par contre, le sommet, c'est cette partie-là qu'il va exposer. Sous-occipitopragmatique.

9,5 cm. Et puis vous avez les autres, bien sûr. Vous n'avez pas que la tête parce que la tête pose problème parce que c'est l'élément le plus solide.

Vous avez le diamètre des épaules. Le diamètre biachromial. Vous avez le diamètre vitre-contérien pour les membres inférieurs.

Donc le bébé, il va passer par la tête, mais aussi par les épaules, par le bassin, son bassin, etc. Et c'est un bloc. Mais le bloc le plus rigide, c'est la tête-cou.

Donc il nécessite la flexion. Et là, on va parler des éléments préparatoires à une présentation de sommet. Avant qu'il soit sommet, il est céphalique dans le grand bassin et c'est une présentation céphalique.

Si vous faites un toucher, c'est une présentation céphalique. C'est au cours de l'accouchement qu'il va devenir fixe et qu'on pourra faire le diagnostic d'une présentation de sommet. Et c'est là qu'on va parler des éléments préparatoires.

Le bébé va réussir, c'est comme un examen. La chance de réussite de cet examen, elle est de combien ? Hein ? 95%. 5% d'échec, c'est toujours la nature, elle ne vous donne jamais 100%.

Quel est le taux de réussite en ce moment ? Quel ? Hein ? 90%. C'est 10% et c'est tout. C'est la même chose ici ? Non.

Ici, il y a... Quel ? C'est dire qu'il y a 20 jours et c'est tout. Mais non, ce n'est pas la règle parce que peut-être c'est les plus brillants qui sont là. Je ne sais pas.

Hein ? Voilà. Vous n'êtes pas un échantillon représentatif. Un échantillon qui représente le 95ème de percentile d'une courbe.

Hein ? Demande-moi les génies de la promotion. Il y a des génies qui sont là. Regardez la distance.

Oui. Il y a la lune et Mars. Tu es seul.

Hein ? Toi-même. Tu n'as personne. Tu le connais ? Tu le connais ? Comment il s'appelle ? Hein ? Ikram ? Tu le connais ? Je ne sais pas.

C'est les 50 ans que je connais. Tu le connais ? Donc cet examen 95% de réussite parce que, premier élément, c'est quoi ? Nous, l'élément numéro un. Vous avez une tête dans le grand bassin et vous avez un détroit.

Qu'est-ce qu'il devrait y avoir ? D'abord, il faut que le bébé... c'est l'orientation. Il va choisir la droite ou la gauche. L'idéal, c'est qu'il parte à gauche.

Donc l'orientation, il doit orienter sa tête. Deuxièmement, la condition sine qua non, c'est la flexion. Il doit fléchir la tête pour pouvoir passer.

La flexion doit être complète. D'accord ? Unbed. Trois, l'asynclitisme.

L'asynclitisme, c'est très simple. Je vous explique. Vous voyez là ? Je peux passer entre les deux chaises.

Comme ça, impossible. Si je fais ça, c'est ça l'asynclitisme. Le bébé va faire la même chose.

Il va faire en sorte qu'il passe les rétrécissements à l'asynclitisme. Le quatrième élément, les adolescents, très important. Le quatrième élément, il n'est pas obligatoire.

Parfois, il peut être pathologique. Ce sont les déformations céphaliques. Je vous ai parlé des fontanelles.

Le crâne n'est pas ossifié. Donc, à cause de la pression, il peut y avoir une diminution du diamètre de la tête rien qu'en chevauchant les os du crâne. Ce chevauchement, s'il dépasse une certaine limite, peut causer des hématomes.

Il peut être source de problèmes. Petite déformation légère, ce n'est pas grave. Mais des déformations importantes, ce n'est pas bien.

Donc, à dos les quatre éléments. À dos les éléments préparatoires à quelle action ? À l'engagement. Une fois qu'il est engagé, comment sait-on qu'il est engagé ? Il faut qu'on fasse le diagnostic.

Rappelez-vous du schéma, le promontoire, et puis le pubis. Et on avait dit qu'il y avait cette ouverture là, d'accord ? Une fois que la tête est là, ça veut dire qu'elle a franchi le détroit supérieur. C'est ça qu'on parle de signes.

On dirigera le doigt vers S2. Et si notre doigt bute contre la tête, ça veut dire que la tête est engagée. Si on arrive à toucher le S2, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas toucher le promontoire parce qu'il est très loin.

Mais S2, vous pouvez la toucher. C'est le signe de Faraboeuf. C'est le signe diagnostique de l'engagement.

Machine d'examen du passant. Le signe de Faraboeuf. Une fois qu'on a fait le diagnostic, on sait que l'étape suivante va être quoi ? Va être la descente de rotation.

Il va descendre le détroit moyen et en même temps, il va essayer de faire la rotation pour ramener, comme je vous ai dit, l'occipite au-dessous du pubis. Une fois qu'il l'a ramenée au-dessous du pubis, il peut commencer à ce moment-là le dégagement. Vous savez qu'il y a un seul obstacle, ce sont les épines.

Et lorsque les épines sont larges, en général, ça se passe très bien. Une fois qu'il a franchi le détroit moyen, il arrive au niveau détroit inférieur. C'est là où il va commencer le dégagement.

Et quels sont les mouvements qu'il va faire au cours du dégagement ? C'est le mouvement contraire. Puisqu'il a fléchi sa tête, il va défléchir sa tête. Ça y est, il va désolidariser sa tête pour qu'il sorte.

Donc il va défléchir. En faisant la déflexion, il va sortir d'abord le front, le nez, la bouche, le

menton, etc. Déflexion de la tête pour sortir.

C'est un moment très important parce qu'il y a une partie osseuse, mais la partie inférieure est plutôt musculaire. Et c'est là où on peut faire l'épisiotomie. Lorsque le diamètre du détroit inférieur ne permet pas la déflexion totale de la tête, on peut s'aider avec une épisiotomie pour élargir le diamètre du détroit inférieur.

Ce n'est pas obligatoire l'épisiotomie. C'est au cas par cas. En général, il y a des indications.

Parce que vous avez des périnées courtes, vous avez des distances anovulvaires courtes. Quel est le risque ? La souffrance ? Oui. Si c'est un tarbe, oui.

La souffrance, oui. Si c'est un tarbe. Quelle souffrance maternelle ? C'est du bassin.

Du périnée. Et la lésion du sphincter de l'anus. Avec un risque d'incontinence anale par la suite.

Pour protéger le sphincter de l'anus, on coupe ces sortes de protections. L'épisiotomie est un acte médical qui doit être utilisé lorsqu'il s'avère que les conditions sont difficiles. Mais il ne faut pas abuser.

Parfois, on trouve que malheureusement les gens font l'épisiotomie juste pour accélérer l'accouchement alors qu'il n'y a pas eu nécessité de faire l'épisiotomie. D'accord ? Parce que l'épisiotomie aussi nécessite une réparation chirurgicale. Et parfois, il y a des problèmes qui peuvent arriver par la suite, notamment les dysparonies, les douleurs chroniques, etc.

C'est un acte qui est quand même invasif. Il faut l'utiliser lorsqu'il y a l'indication. D'accord ? Alors, la présentation de sommet, comme vous l'avez vu, elle passe par ces trois actions.

L'accouchement proprement dit, vous voyez que l'accouchement en général se fait sans l'aide de personne. Et nous, on va aider à quelle action ? Le dégagement. Le dégagement qui est la dernière partie.

La cerise sur le gâteau. Ça veut dire que la nature a déjà fait le grand boulot pour vous et vous venez faire l'acte. Les gens qui prennent des photos sur Instagram, Facebook.

C'est pas bien ? C'est pas bien ? C'est bien ? C'est pas bien ? Respecter l'intimité des femmes. Il faut aussi respecter le métier de médecin. Parce que le problème de la médecine, alors vous allez vivre cela, hein ? La vulgarisation de la médecine.

Là, on assiste à une vulgarisation de la médecine pour le grand public, pour les non-médecins. Vous n'aurez aucune arme. Parce que vous avez tout montré aux gens qui ne sont pas médecins, ils peuvent vous attaquer.

Alors quand vous laissez votre métier dans son coin, où il doit être, dans les hôpitaux, dans les structures de santé, pas dans les rues, pas dans les cafés, dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas

de YouTubeur ici. Il n'y a pas de YouTubeur ici.

Il n'y a personne ? Personne ? Toi ? Non ? T'as gâte ? Je connais la tablette. Non ? Hein ? Qui est pour la vulgarisation de la médecine pour le grand public ? Vous voulez que je fasse un petit sondage ? Personne ? Attends. Une seule fois.

Un peu pour. Vous êtes pour, les autres contre. La médecine et la sensibilisation, c'est autre chose.

La sensibilisation, c'est le travail du ministère, normalement. Je vous donne un exemple. On sait par exemple qu'il y a un matin, on va constater une épidémie, ou l'augmentation du nombre de cas de cancer du col, par exemple.

Et on sait qu'il y a un test de dépistage. On va sensibiliser la population à venir faire le test, parce qu'on va détecter le cancer précocement, on va le traiter précocement. Il y a la sensibilisation.

La vulgarisation, il y a ce que je vous dis. Il le met sur Facebook. Il vulgarise.

Voilà, je suis en train de couper. Dégagement des traits inférieurs. C'est ça.

La sensibilisation, c'est bien. C'est bien la sensibilisation. La vulgarisation, c'est autre chose.

T'as l'église de Napour ? En public, là. Là, tu parles de sensibilisation. C'est bien.

On va voir ce que l'avenir va nous dire, parce que vous aurez la réponse en fonction des conséquences. Quels que soient les arguments pour ou contre, c'est l'action de la société. Comment la société va se déformer ? Si les médecins vont pouvoir exercer leur métier difficilement à cause de cette vulgarisation, et qu'ils vont être poursuivis chaque fois, parce qu'on va dire que c'est une erreur, ça va pourrir la vie des médecins.

Ça peut faire fouir les gens de la profession médicale. On va voir la réponse. On l'aura dans le futur.

Je voulais vous parler d'une chose importante aussi. En fait, du travail, de la durée du travail normal. Vous avez fait ça ? La durée du travail normal ? Fait une présentation de sommet.

Présentation de sommet compatible avec un accouchement normal. Combien il y a de phases d'accouchement, de travail ? Il y a deux phases. Il y a une phase active, une phase de latence.

C'est là, une courbe. Vous avez deux phases. Une phase de latence et une phase active.

La phase active va durer une moyenne de huit heures. Elle va commencer par exemple, de la direction du col, et va aller tout doucement. Une fois elle atteint les 3-4 cm de diamètre, à ce moment-là, il y aura une accélération.

Accélération, puis, phase de descente avec une phase, ça correspond à la dilatation complète qui est 10 cm. Et vous avez en général, entre la dilatation complète et l'accouchement, une heure. D'accord ? Ça, c'est la phase active.

Ça, c'est la phase de latence. La phase de latence peut être très lente, surtout chez la première part. La phase active, en général, est très accélérée, et elle est plus accélérée chez la multipart.

Mais la règle générale, c'est 1 cm par heure. Ça peut être plus, mais c'est 1 cm par heure. Apprécié, bien sûr, au toucher vaginal.

D'accord ? En général, dans une présentation de sommet, avec un bassin normal, avec un point normal, les choses, en général, vont se passer au maximum dans les 14 heures, 12 à 14 heures, la patiente aurait accouché. À partir du moment où elle a entamé le travail. Quand on dit entamer le travail, ça veut dire des contractions efficaces et qui entraînent une dilatation du col.

On ne parle pas de la femme qui est un peu mal, qui vient aux urgences. Vous voyez, parfois, vous êtes déjà patient dans le service ? Non ? Dans la salle d'accouchement, parfois, on examine les patientes. Elles commencent à crier, et puis on leur dit, revenez, faites un tour et revenez.

Parce que, tout simplement, elle n'est pas encore en train d'entamer son travail normal. Et du coup, on peut se permettre, parce qu'on ne peut pas admettre tout le monde. Sinon, on va admettre les patientes qui vont accoucher dans deux ou trois jours et on va remplir le service.

Il faut qu'on admette vraiment les femmes en phase de latence. C'est vrai, pour au moins s'assurer que la patiente va accoucher dans les 12 heures. Si elle est admise à 6 heures de l'après-midi, on va dire au maximum 6 heures du matin, elle aurait accouché.

C'est clair. C'est pour ça que, parfois, il y a des patientes qui râlent parce qu'on leur dit, je suis partie à l'hôpital deux ou trois fois, ils m'ont examinée, ils ne veulent pas m'hospitaliser. Parce qu'elles ne font pas la différence entre les vraies contractions et les fausses contractions.

Les fausses contractions n'entraînent rien du tout. Pas de dilatation. Les vraies contractions entraînent une dilatation.

Vous me regardez les yeux comme ça, vous n'avez pas vu ça ? Hein ? Vous avez étudié la phase de latence, la phase active ? Les anomalies de la phase de latence ? Les anomalies de la phase active ? Hein ? Là ? Hum ? Non ? OK. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai préféré vous faire le cours comme ça, à l'ancienne, pour éviter l'ennui des diapositifs, du PowerPoint. Oui ? En principe, non.

Les bébés qui sont engagés en occipitaux sacrés sont les bébés en variété postérieure. Quoique, la plupart des bébés chez les primipares, même s'ils sont en variété postérieure, ils vont tourner

vers l'occipite, vers le pubis. Ils vont faire une grosse rotation.

D'accord ? C'est la règle. L'occipite au pubien. Et l'occipite au sacré, en général, vous avez certaines variétés postérieures, lorsque la musculature n'est pas capable de faire tourner le bébé, il va choisir le chemin le plus facile.

C'est le sacrum. Le diamètre de dégagement de l'occipite au sacré est important. Vous avez plus de risque de déchirure du périnée par rapport au dégagement en occipite au pubien.

Donc c'est délétère aussi pour le périnée. Il y a plus d'épisodes. En général, on fait presque des épisodes systématiques.

L'occipite au sacré. Parce qu'il y a vraiment une action prolongée sur le périnée et un étirement très important du périnée. D'autres questions ? Tout est clair ? Donc vous avez tout compris ? Hein ? Vous avez tout compris ? Un peu.

Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Tu as compris ? Sauf que si vous n'avez pas de questions, je peux vous libérer et ensuite, inshallah, la prochaine séance pour voir les autres cours ensemble. Voilà, bon courage !